



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صفاء الصباحى ابراهيم نصار

العنوان : --

الحي / المدينة : شبين الكوم

المحافظة : المنوفية

تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

رقم البطاقة : 26711241700188 رقم التليفون : 01061562130

العمر (تاريخ الميلاد) : 24-11-1967 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا أتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين علي الفقرات العنقيه والصدرية بالصبغه [1112]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صفاء الصباحي ابراهيم نصار National ID: 26711241700188	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي MRI cervical and thoracic spine with contrast
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name	: الأستاذ / صفاء الصباحي ابراهيم نصار	Request No.	: 131535
Patient No.	: 26711241700188	Request Date	: 09/12/2021
Path No.	: 3043/21	Verification Date	: 13/12/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast mass

Nature of the specimen:
Tru cut biopsy

Gross Examination:
Four gray white tissue cores up to 1.5cm, totally submitted.

Microscopic examination:
• Histological type: IDC
• Grade II
• Angioinvasion: no
• Ductal carcinoma in situ: no

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GII
For (ER, PR, Her2, Ki67)

Prof.Gamal AbdelAty
Dr.Rana Fathy

Verified by :
iman gouda

Printing Date : 01/08/2024 10:58:53

Page 1 of 1

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Name: صفاء الصباحي ابراهيم نصار		
MR. : 7173		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
Post-mastectomy left breast cancer, clinical stage CT3, no metastasis. Histology: IDC grade 2, ER 6/8, PR 6/8, HER2-negative. Ki-67 10%. The patient underwent left whole-breast irradiation (WLE) with a boost to the tumor bed (YPT2, YPN0/2). Post-operative chemotherapy was completed (4 cycles). A port was placed in the left femoral vein in March 2022 for subsequent systemic therapy. The patient is currently receiving Femara (letrozole) and Zometa (zoledronic acid) for bone-protective therapy.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	dina makram	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



مبادرة رئيس الجمهورية
لحماية المرأة المصرية

Question 1

MDT FORM

281712022

۴۰

Name	بستان الصبيح إبراهيم	MRN	0109/001
Age	53	ID	27011240-110
Menopausal status		Phone	1-77216199
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:

ER:

PR:

HER 2:

Ki67:

618

618

— 12

167:

Sonomammography :

Mets Workup:

Recommendations:

- MRI D. esp. honey

- CGSM $\rightarrow$ unifocal 5.1 x 4 x 4.8 cm (1 cm from anterior mesocol)

Rec'd Sm. f H-act - m - 1/2 of

MDT OUTCOME & PLAN

والله اعلم

mass. Conc. Dimeson 4 (X Zone)
without loss of cleavage from
for C.G. m. - Remot^{muscles}
Comp. & Study

13/2/22 $\rightarrow$ CESM $\rightarrow$ PR

for Lr BCS + ~~LN~~ B (+ wind locally)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY

MDT Form

[DOCTYPE:MDT FORM]

MDT FORM

Name	شاهين احمد
Age	53y
MRN	5711551111111111
ID	
Co morbidity	DM



Tel 3 01066385194

Clinical Data

Bx:	H IDC grade II	SM: Lt breast mass at 11 o'clock 2.4 X 2.3 cm	BIRAD 4B
IHC:		Mets Workup:	
ER:	4ve 6/8	CT	→ bilateral tiny subpleural
PR:	4ve 6/8		Pulm. nodule for follow
HerY:	ve		→ D3 & D1 lytic lesion
KITV:	low	Bone scan	→ free
COMMENT:	4cm	CLT3 No Mo	
SM → unifocal mass, No axill. W, (11/2022)			

MDT OUTCOME & PLAN

26-2-2022 → Postmenop. + Humoral A ⇒ Mostly Mets

* For ⇒ - ~~MR T~~ MRI Dorsal spine

- CESM + target axilla US

- Meanwhile start A.I. + 2 mets if Mets ⇒

Continue A.I.

- if not mets ⇒ surgery acc to CESM

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



Dms
فيما
المتوفية



Patient's Name:

Safaa Al-Sabbahi Ibrahim Nassar

Date:

2026-09-06

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Post left CBS a, routine follow up study.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b).
- Retroareolar focal asymmetry with round calcifications.
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- UOQ small intrammary Ln .
- Ultrasound demonstrated stationary benign lesion measuring 8 mm .
- 10 o'clock , zone 3 small benign intramammary LN .
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Thickened skin and coarsen trabeculae.
- UIQ architectural distortion with no speculations, masses, asymmetry , or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated UIQ area of parenchymal disruption underneath the operative scar with no solid , cystic lesions or fluid collections.
- Thickened skin reaching 5 mm and coarsen trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Clear left axilla. No pathological infra or supra-clavicular lymph nodes
-

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): Beniong findings**
- **Left breast (BIRADS 2): Post-therapeutic sequelae.**

Recommendation:-

For annual follow up.

Prof.MONA ZAKY

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
مراكز الرعاية الطبية المتخصصة
مستشفى أوزام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Safaa Al Sabbahy Ibrahim Nassar	Date : 17/07/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 5179/2021	Pat. ID: 15178

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Left UIQ spiculated dense mass with surgical clip seen within
- Right breast retro areolar distortion with benign calcifications.

Complementary ultrasound :

- Left 10 O'clock irregular hypoechoic solid mass , measured about 4.5 x 2 cm
- Right breast retroareolar distortion covering an area measures about 1.3 x 3 cm with oval shaped isoechoic lesion within measures 0.7 cm in diameter.
- Right UOQ intra mammary lymph node pathologically proven benign.
- Nonspecific bilateral axillary LNs.

Opinion:

- Left UIQ pathologically proven carcinoma showing partial therapeutic response (BIRADS6)
- Right breast retroareolar distortion pathologically proven inflammatory process for prober medical treatment and follow up (BIRADS3)

Yours truly

Signature Dr. Aya Deabes
17/07/2022 3:50 PM